

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE EVALUACIÓN DE ACATISIA DE BARNES (BARS)

Eje VI: Farmacovigilancia y Síntomas Motores • Estándar Oro de Acatisia Inducida de Thomas Barnes

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Evaluación de Acatisia de Barnes (BARS; versión clínica estructurada).
Nombre Original	Barnes Akathisia Rating Scale (BARS; Barnes, 1989; Imperial College London).
Autores Originales	Thomas R. E. Barnes, M.D., FRCPsych (Charing Cross and Westminster Medical School).
Adaptaciones Hispanas	Bobes et al. (2002); Bulbena et al.; Grupo CIBERSAM de Psicofarmacología, España.
Eje Clínico y Constructo	Eje VI: Somática y Efectos Secundarios. Acatisia motora y desasosiego subjetivo farmacológico.
Tipo de Instrumento	Escala heteroaplicada mixta (observación motriz directa y entrevista clínica subjetiva).
Composición de Ítems	4 ítems clínicos (Acatisia Objetiva, Inquietud Subjetiva, Sufrimiento y Juicio Global).
Población y Rango	Pacientes de cualquier edad tratados con antipsicóticos o bloqueadores dopaminérgicos.
Tiempo de Administración	5 a 8 minutos de observación directa (sentado y de pie) y entrevista dirigida.
Régimen de Licencia	Dominio público para uso asistencial clínico y ensayos farmacológicos internacionales.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL DESASOSIEGO DE LA ACATISIA

La **BARS** es el instrumento de referencia mundial para el diagnóstico diferencial y monitorización de la acatisia inducida por psicofármacos:

- Doble Componente Indispensable:** La acatisia combina una sensación psíquica insoportable de inquietud o tensión interior con una compulsión irreprimible a mover las extremidades inferiores (incapacidad de permanecer sentado).
- Riesgo Clínico de Confusión con Agitación:** Uno de los errores psiquiátricos más graves es confundir la acatisia motora con una exacerbación psicótica o maníaca; aumentar la dosis de antipsicótico en esa situación multiplica el sufrimiento y eleva drásticamente el riesgo de suicidio impulsivo.
- Observación Postural Dinámica:** La prueba exige observar al paciente tanto en posición sentada como de pie, dado que la inquietud se desenmascara preferentemente en reposo forzado.

3. COMPONENTES Y ESTRUCTURA DE LOS 4 ÍTEMES CLÍNICOS

Sección Clínica BARS	Rango	Criterios Operativos de Observación y Pregunta Clínica
1. Acatisia Objetiva	0 a 3 puntos	Signos observables: golpeteo continuo de pies, cruce/descruce incesante de piernas, balanceo o necesidad de levantarse y pasear.
2. Inquietud Subjetiva	0 a 3 puntos	Conciencia interna: sensación de tirantez o desasosiego en las piernas y urgencia compulsiva irresistible de moverse.
3. Angustia / Sufrimiento	0 a 3 puntos	Impacto afectivo: nivel de malestar emocional, disforia, irritabilidad o desesperación atribuida a la inquietud.
4. Evaluación Global	0 a 5 puntos	Juicio diagnóstico ponderado del examinador: 0 (Ausente) a 5 (Acatisia severa e incapacitante).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Las validaciones clínicas de la BARS (Barnes, 1989; Bobes et al., 2002; Poyurovsky, 2010; $N > 500$) demuestran excelencia métrica:

Propiedad Psicométrica	Coficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Concordancia Interevaluador	CCI = 0.89 - 0.95	Extraordinaria consistencia entre observadores clínicos independientes.
Consistencia Interna	Alfa de Cronbach = 0.85 - 0.90	Alta coherencia entre signos objetivos y reporte de inquietud subjetiva.
Sensibilidad Diagnóstica	Sensibilidad = 94%	Identificación precisa de acatisia incipiente tras aumento de antipsicótico.
Especificidad Diagnóstica	Especificidad = 91%	Distingue acatisia de discinesia tardía, síndrome de piernas inquietas y manía.
Sensibilidad al Cambio	Efecto $d = 1.20$ (post-betabloqueante)	Captura inmediata de la respuesta terapéutica a propranolol o benzodiazepinas.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- **Puntuación Total de la BARS (Ítems 1 + 2 + 3):** Se suman los tres primeros ítems:

$$\text{Puntuación Total BARS} = \text{Objetiva (1)} + \text{Inquietud (2)} + \text{Angustia (3)} \quad (\text{Rango: 0 a 9 puntos})$$

- **Ítem 4: Evaluación Clínica Global (Puntuación Separada de 0 a 5):** No se suma al total; se consigna como índice de severidad clínica: 0 = Ausente; 1 = Dudosa / cuestionable; 2 = Acatisia leve; 3 = Acatisia moderada; 4 = Acatisia marcada; 5 = Acatisia severa / incapacitante.

- **Criterio Diagnóstico Canónico de Barnes:** Una puntuación de ≥ 2 en el **Ítem Global 4** confirma el diagnóstico de acatisia clínicamente significativa.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntos (1-3)	Ítem Global 4	Estado Clínico y Decisión Terapéutica (Barnes)
Sin Acatisia	0 puntos	0 (Ausente)	Ausencia de inquietud motriz u objetiva; mantener vigilancia.
Acatisia Dudosa	1 a 2 puntos	1 (Cuestionable)	Inquietud leve inconstante; reevaluar en 48 horas sin cambiar fármaco.
Acatisia Leve	3 a 4 puntos	2 (Leve)	Punto de corte diagnóstico reducir antipsicótico o pautar betabloqueante.
Acatisia Moderada	5 a 6 puntos	3 (Moderada)	Malestar notable imposibilidad de estar quieto; riesgo de abandono.
Acatisia Severa	7 a 9 puntos	4 - 5 (Grave)	Emergencia clínica angustia extrema; riesgo de autolesión o suicidio.

PUNTO DE CORTE DIAGNÓSTICO OFICIAL (BARS GLOBAL ≥ 2 PUNTOS):

Una puntuación ≥ 2 en la **Evaluación Clínica Global** (acompañada típicamente de una puntuación total ≥ 3) ratifica formalmente la presencia de acatisia inducida por psicofármacos. Esto exige una acción correctiva farmacológica inmediata (reducir antipsicótico, iniciar Propranolol 20-40 mg/día o clonazepam) para evitar el riesgo inminente de intento autolítico disfórico.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN MÉDICA ANTE SOSPECHA DE ACATISIA AGUDA

PROTOCOLO DE URGENCIA PSIQUIÁTRICA CON LA ESCALA BARS:

- **Paso 1 (Exploración Observacional y Anamnesis):** Observar al paciente sentado durante 3 minutos y de pie durante 2 minutos; preguntar textualmente: “¿Siente dificultad para estar quieto, o una tensión en el cuerpo que le obliga a mover las piernas?”.
- **Paso 2 (Diagnóstico Diferencial Ineludible):**
 - Si el paciente presenta agitación pero **niega sensación de desasosiego interno** en piernas → Agitación psicótica pura o manía.
 - Si el paciente presenta **desasosiego interno insoportable con balanceo** de piernas → **Acatisia inducida por neurolépticos**.
- **Paso 3 (Intervención Terapéutica Inmediata):**
 - Prohibido aumentar la dosis del antipsicótico.
 - Reducir la dosis del agente causal (p. ej. aripiprazol, risperidona, haloperidol).
 - Iniciar **Propranolol** (10 a 40 mg cada 12 horas, vigilando presión arterial y frecuencia cardíaca) o una benzodiacepina (**Clonazepam** 0.5 a 1 mg).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: CONFUSIÓN DE ACATISIA CON EMPEORAMIENTO PSICÓTICO

Identificación: Mujer de 26 años con primer episodio de psicosis no esquizofrénica, ingresada en sala de agudos, en tratamiento con Aripiprazol aumentado hace 48 horas de 10 a 20 mg/día. El personal de enfermería reporta que la paciente “está muy agitada, entra y sale de la habitación continuamente y no tolera estar sentada”, sospechando reagudización del delirio.

Evaluación Clínica con la Escala BARS:

- **Ítem 1 (Acatisia Objetiva): 3 puntos** (cruza y descruza las piernas de forma continua al sentarse; a los 40 segundos se pone de pie y camina en círculos por la consulta).
- **Ítem 2 (Inquietud Subjetiva): 3 puntos** (describe “una tortura interior en las piernas, como si tuvieran un motor por dentro que no me deja parar”).
- **Ítem 3 (Angustia / Sufrimiento): 3 puntos** (llanto desconsolado y quejas de desesperación inaguantable).
- **Ítem 4 (Evaluación Global): 4 puntos (Acatisia severa, netamente patológica).**

Resolución Médica: Se canceló la orden de administrar antipsicóticos de rescate; se redujo el aripiprazol a 10 mg/día y se pautó Propranolol 20 mg cada 12 horas con Clonazepam 1 mg sublingual.

Evolución: A las 3 horas de la primera dosis de betabloqueante, la paciente se encontraba sentada y en calma (BARS global = 0), demostrando que la conducta correspondía a un efecto secundario extrapiramidal agudo y no a resistencia antipsicótica.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

RIESGO ELEVADO DE SUICIDIO:

La acatisia grave genera una disforia insoportable asociada a intentos autolíticos impulsivos; constituye una urgencia psiquiátrica no demorable.

SÍNDROME DE PIERNAS INQUIETAS:

El SPI empeora por la noche en cama y mejora al caminar; la acatisia por neurolépticos está presente durante todo el día independientemente del horario.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Barnes, T. R. (1989). A rating scale for drug-induced akathisia. *The British Journal of Psychiatry*, 154(5), 672-676.
2. Barnes, T. R. (2003). The Barnes Akathisia Rating Scale: Revisited. *Journal of Psychopharmacology*, 17(4), 365-370.
3. Poyurovsky, M. (2010). Acute antipsychotic-induced akathisia: Revisiting a common yet overlooked adverse effect. *CNS Drugs*, 24(9), 743-752.
4. Bobes, J., et al. (2002). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica*. Ars Médica.